

OK - sistema.

INDICADO POR: Silvia psicólogo / Alexandre
☒ ACOMPANHAMENTO ☐ CONSULTA
NS 22242217447 | 818

ALCIDES HILDEBERTO PINTO DE OLIVEIRA

IDADE: 55a PESO: 130 ALTURA: 1,76 PROFISSÃO: 7 Coord. Contábil
SINTOMAS: o período trabalho. extensas em SP.

QUEIXAS: Dorco; Acorda Comado;

MEDICAMENTOS: —

MÉDICO: Dr. Paulo Roberto / Dr. Gustavo - Cardiol

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: nas faz

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S () N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 26,5elh

SPO2: 86%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRRAFIA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

02/04/2025 Avaliação Auto 45-40 cmH2O Máx Dream Ulean (M)

07/05 P= 5,8 cmH2O BNC

25 m. de uso: 4h50'

Fuga = 14,6

traco apneico pelo SIO.

16/05 P= 6 cmH2O

25 IAH= 0,8elh

Deleta estar a Torne lica

m de uso: 5h58'

fuga: 15,1 elm

18/06 P= 6 cmH2O

25 IAH= 0,9elh

Natasha

25 m. de uso: 6h40'

Fuga = 1,3 epu.

luc

Nome: ALCIDES HILDEBERTO PINTO DE OLIVEIRA
Data de Nascimento: 20-7-1970
IMC: 41,00
Sexo: Masculino
Data do exame: 07-09-2024

Peso: 127 kg
Altura: 1,76 m
Médico: DR. PAULO ROBERTO
FIGUEIREDO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 07-09-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 449,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 14,0 e 45,5 minutos. O tempo total de sono foi de 321,5 min, eficiência de 71,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 4,7%; estágio N2: 56,1%; estágio N3: 16,8%; sono REM: 22,4%. O índice de despertares foi de 10,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopnéia total foi de 26,5/hora, sendo 59 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 60 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 86%, permanecendo 1,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 47 - 92 bpm e NREM de 47 - 88 bpm.

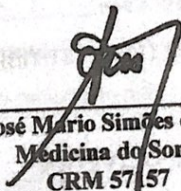
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (13), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 26,5/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2 = 86%);
5. latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,1/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157